



Prise en charge du patient souffrant de céphalées

Par **[Stephen D. Silberstein](#)**, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University

Reviewed By **[Michael C. Levin](#)**, MD, College of Medicine, University of Saskatchewan

Vérifié/Révisé févr. 2025

Les céphalées sont des douleurs de la région crânienne, incluant la voûte, la face (dont la région orbitotemporale) et l'intérieur du crâne. Les céphalées sont l'un des motifs les plus fréquents de consultation.

Physiopathologie des céphalées

Les céphalées sont dues à l'activation de récepteurs sensibles à la douleur dans ou autour du cerveau, du crâne, de la face, des sinus ou des dents.

Étiologie des céphalées

Les céphalées peuvent être primaires ou secondaires à une autre pathologie.

Les **céphalées primaires** comprennent les suivantes:

- [Les céphalées de tension](#)
- [La migraine](#)
- Céphalées autonomes du trijumeau (dont les algies vasculaires de la face [céphalée en grappe], l'hémicranie paroxystique chronique, l'hémicranie continue et les [céphalées névralgiformes de courte durée et unilatérales, accompagnées d'injection conjonctivale et de larmoiement \[SUNCT, short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing\]](#))

Les **céphalées secondaires** ont de nombreuses causes (voir tableau [Troubles responsables de céphalées secondaires](#)).

Globalement, les **causes les plus fréquentes de céphalée** sont les suivantes

- Les céphalées de tension

- La migraine

Certaines causes de céphalée sont fréquentes; d'autres sont importantes à identifier parce qu'elles sont dangereuses et/ou nécessitent un traitement spécifique (voir tableau [Certaines caractéristiques des céphalées selon leur cause](#)).

TABLEAU

Troubles responsables de céphalées secondaires

Cause	Exemples
Pathologies extra-crâniennes	Dissection de l'artère carotide interne ou vertébrale (qui peut aussi engendrer une douleur cervicale) Affections dentaires (p. ex., infection, dysfonction de l'articulation temporomandibulaire) Glaucome Sinusite
Pathologies intracrâniennes	Tumeurs cérébrales et autres lésions expansives Malformation de Chiari type I Fuite de liquide céphalorachidien avec céphalées par hypotension intracrânienne Hémorragie (hémorragie intracérébrale , hémorragie sous-durale , hémorragie sous-arachnoïdienne) Hypertension intracrânienne idiopathique Infections (p. ex., abcès , encéphalite , méningite , empyème sous-dural) Méningite non infectieuse (p. ex., carcinomateuse, chimique) Hydrocéphalie obstructive Troubles vasculaires (p. ex., accident vasculaire cérébral ischémique , accident vasculaire cérébral hémorragique ,

Cause	Exemples
	<u>malformations vasculaires, vascularite, thrombose du sinus veineux</u> Thrombose du sinus veineux cérébral
Troubles systémiques	<u>HTA</u> sévère aiguë <u>Bactériémie</u> <u>Fièvre</u> <u>Artérite à cellules géantes</u> <u>Hypercapnie</u> Hypoxie (dont <u>mal d'altitude</u>) Syndrome de tachycardie orthostatique posturale Infections virales
Médicaments, autres substances et toxines	Abus d'antalgique Sevrage en caféine <u>Monoxyde de carbone</u> Hormonothérapie (p. ex., œstrogènes) Nitrates Inhibiteurs de la pompe à protons

TABLEAU

Certaines caractéristiques des céphalées selon leur cause

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
Céphalées primaires†		
<u>Algies vasculaires de la face (céphalée en grappe)</u>	Crises unilatérales orbitotemporales multiples survenant souvent au même moment de la journée Profonde, très intense, durant 30–180 min	L'anamnèse et l'examen clinique seuls

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	Souvent avec larmoiement, rhinorrhée, rougeur du visage (bouffées vasomotrices) ou syndrome de Claude Bernard-Horner ; agitation	
Migraine	Unilatérale ou bilatérale et pulsatile, durant 4–72 h Parfois avec aura Habituellement, nausées, photophobie, sonophobie ou osmophobie Aggravée par l'effort, calmée par le repos dans l'obscurité, résolution avec le sommeil	L'anamnèse et l'examen clinique seuls
Les céphalées de tension	Douleur fréquente ou continue, d'intensité modérée, bilatérale, à type de sensation d'étau occipitale ou frontale s'étendant à l'ensemble du crâne Maximale en fin de journée	L'anamnèse et l'examen clinique seuls
Céphalées secondaires		
Glaucome aigu par fermeture de l'angle	Frontal ou orbitaire unilatéral Halos colorés, baisse de l'acuité visuelle, injection conjonctivale, vomissements	Tonométrie
Maladie d'altitude	Vertiges, anorexie, nausées, vomissements, fatigue, irritabilité, troubles du sommeil	L'anamnèse et l'examen clinique seuls

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	Chez les patients qui se sont récemment rendus dans des lieux à une altitude élevée (y compris voler ≥ 6 heures en avion)	
Intoxication par le monoxyde de carbone	Exposition à des hydrocarbures incomplètement brûlés (p. ex., incendies domestiques, voitures mal ventilées, appareils de chauffage au gaz, chaudières, chauffe-eau, poêles à bois ou à charbon, appareils de chauffage au kérosène).	Taux de carboxyhémoglobine
Thrombose du sinus veineux cérébral	Des symptômes similaires à ceux de l'hypertension intracrânienne idiopathique mais peuvent commencer soudainement	Neuro-imagerie (de préférence IRM avec veinographie par résonance magnétique)
Céphalées cervicogènes	Douleur dans la région du cou	L'anamnèse et l'examen clinique seuls
Infections dentaires (des dents supérieures)	Douleur habituellement ressentie sur le visage, la plupart du temps unilatérale et aggravée par la mastication. Odontalgie	Examen dentaire
Encéphalite	Fièvre, altération de la conscience, convulsions, déficits neurologiques focaux	IRM, analyse du liquide céphalorachidien
Artérite à cellules géantes	Âge > 50 ans Douleur lancinante unilatérale,	VS, biopsie de l'artère temporale, habituellement neuro-imagerie

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	hypersensibilité du cuir chevelu lorsque le patient se coiffe, troubles visuels, claudication de la mâchoire, fièvre, perte de poids, sueurs, sensibilité de l'artère temporale, myalgies proximales	
Céphalées hypertensives	Associées à une augmentation brutale de la PA	Bilan clinique
Hypertension intracrânienne idiopathique	Céphalées de type migraine, diplopie, acouphènes pulsatiles, perte de la vision périphérique, œdème papillaire Habituellement début progressif	Neuro-imagerie (de préférence IRM avec phlébo-IRM), suivie d'une mesure de la pression du liquide céphalorachidien et d'une culture et d'une analyse du nombre de cellules
Hémorragie intracérébrale	Début brutal Vomissements, déficit neurologique focal, altération de la vigilance	Neuro-imagerie
Céphalée par surconsommation de médicaments	Céphalées chroniques (habituellement migraine chronique) avec localisation et intensité variables Se produit fréquemment et peut être quotidien Souvent présente au réveil Se développe habituellement après un abus d'analgésiques en cas de céphalée épisodique	L'anamnèse et l'examen clinique seuls

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
<u>Méningite</u>	Fièvre, syndrome méningé, altération de la vigilance	Analyse du liquide céphalorachidien, souvent précédée d'une TDM
Céphalées post-coïtales	Céphalées après l'orgasme	L'anamnèse et l'examen clinique seuls
<u>Céphalées post-ponction lombaire et autres céphalées par hypotension du liquide céphalorachidien</u>	Céphalées intenses, souvent avec syndrome méningé et/ou vomissements Aggravée lorsque le patient est assis ou debout et soulagée lorsque le patient est en position allongée	Pour la céphalée post-ponction lombaire, évaluation clinique Pour les autres céphalées à basse pression (p. ex., fuites de liquide céphalorachidien), parfois IRM avec contraste au gadolinium
Céphalées post-traumatiques (habituellement une migraine ou une céphalée de tension)	Similaire à la migraine, aux céphalées de tension et aux douleurs cervicales	L'anamnèse et l'examen clinique seuls
<u>Sinusite</u>	Douleur faciale ou dentaire positionnelle, fièvre, rhinorrhée purulente	L'anamnèse et l'examen clinique, parfois la TDM
<u>Hémorragie sous-arachnoïdienne</u>	Intensité maximale quelques secondes après le début de la céphalée (céphalée en coup de tonnerre) Vomissements, syncope, obnubilation, syndrome méningé	Neuro-imagerie, suivie d'une analyse du liquide céphalorachidien en l'absence de contre-indications et si l'imagerie n'a pas été contributive
<u>Hématome sous-dural</u> (chronique)	Somnolence, altération de la vigilance, hémiparésie, perte des pulsations veineuses rétinienes	Neuro-imagerie

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	spontanées, œdème papillaire Présence de facteurs de risque (p. ex., âge avancé, antécédents de traumatisme crânien, coagulopathie, démence, utilisation d'anticoagulants, abus d'éthanol)	
<u>Névrалgie du trijumeau</u>	Douleur courte, répétée et lancinante sur un côté de la partie inférieure de la face	L'anamnèse et l'examen clinique seuls
<u>Tumeur</u> ou masse	Finalement, altération de la conscience, convulsions, vomissements, diplopie lors du regard latéral, perte des pulsations veineuses rétinienne spontanées ou œdème papillaire, déficit neurologique focal Aggravé par le décubitus; pire au réveil ou réveille le patient au cours du sommeil	Neuro-imagerie
* Une anamnèse et un examen clinique sont toujours effectués mais ne sont mentionnés dans cette colonne que lorsqu'ils peuvent être le seul moyen diagnostique. † Les céphalées primitives sont habituellement récidivantes. PA = pression artérielle; LCR = liquide céphalorachidien; VS = vitesse de sédimentation érythrocytaire.		

Évaluation des céphalées

L'évaluation des céphalées se concentre sur

- La détermination de la présence d'un mal de tête secondaire
- La recherche de symptômes qui suggèrent un trouble sous-jacent grave

Lorsqu'aucune cause ou aucun symptôme grave n'est retrouvé(e), l'évaluation se concentre sur les troubles primaires des céphalées.

Une céphalée récente après l'âge de 50 ans doit être considérée comme une céphalée secondaire jusqu'à preuve du contraire.

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie** comprend des questions sur les caractéristiques de la céphalée:

- Localisation
- Durée
- Intensité
- Début (p. ex., brusque, progressif).
- Qualité (p. ex., pulsation, constante, intermittente, à type de pression)

Les facteurs d'aggravation et d'amélioration sont notés (p. ex., position de la tête, période de la journée, sommeil, lumière, bruits, activité physique, odeurs, mastication). On demande aux patients si les céphalées ne surviennent qu'en position debout; ces céphalées sont préoccupantes car elles peuvent être causées par une fuite de liquide céphalorachidien ou par un syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Si le patient a des céphalées anciennes ou récidivantes, les diagnostics antérieurs (s'il y en a eu) doivent être retrouvés, et il faut préciser si les céphalées actuelles sont similaires ou différentes. En cas de céphalées récidivantes, on note ce qui suit:

- Âge de début
- Fréquence des épisodes
- Schéma temporel (dont toute relation avec la phase du cycle menstruel)
- Réponse aux traitements (y compris aux traitements en vente libre)

La **revue des systèmes** doit rechercher des symptômes évoquant une cause dont

- Vomissements: [migraine](#) ou hypertension intracrânienne
- Fièvre: infection (p. ex., [encéphalite](#), [méningite](#), [sinusite](#))
- Œil rouge et/ou symptômes visuels (halos, flou visuel): [glaucome aigu par fermeture de l'angle](#)
- Déficit du champ visuel, diplopie ou flou visuel: migraine oculaire, lésion expansive cérébrale, ou [hypertension intracrânienne idiopathique](#)

- Larmoiement et rougeur du visage (bouffées vasomotrices): [algies vasculaires de la face \(céphalée en grappe\)](#)
- Rhinorrhée: sinusite
- Acouphènes pulsatiles: hypertension intracrânienne idiopathique
- Aura inaugurale: migraine
- Déficit neurologique focal: encéphalite, méningite, [hémorragie intracérébrale](#), [hématome sous-dural](#), [tumeur](#) ou autre lésion expansive
- Convulsions: encéphalite, tumeur ou autre lésion expansive
- Perte de connaissance lors de l'installation de la céphalée: [hémorragie sous-arachnoïdienne](#)
- Myalgies et/ou modifications visuelles (chez les sujets de > 50 ans): [artérite à cellules géantes](#)

La recherche des **antécédents médicaux** doit identifier les facteurs de risque de céphalées, y compris l'utilisation de médicaments ou de substances (en particulier la caféine), le sevrage de la caféine, l'exposition à des toxines (voir tableau [Troubles responsables de céphalées secondaires](#)), une ponction lombaire récente, l'utilisation d'immunosuppresseurs ou de médicaments IV (risque d'infection), une hypertension (risque d'hémorragie cérébrale), un cancer (risque de métastases cérébrales), une démence, un traumatisme, une coagulopathie ou l'utilisation d'anticoagulants ou d'éthanol (risque d'hématome sous-dural).

L'anamnèse sociale et familiale doit aussi rechercher tout antécédent familial de céphalées, notamment parce que la migraine peut ne pas avoir été diagnostiquée chez d'autres membres de la famille.

Pour simplifier la collecte de données, on peut demander aux patients de remplir un questionnaire de céphalées qui couvre la plupart de l'anamnèse pertinente du diagnostic des céphalées. Les patients peuvent remplir le questionnaire avant leur visite et apporter les résultats avec eux.

Examen clinique

Les signes vitaux, dont la température, sont mesurés. L'aspect général (p. ex., si le patient est agité ou calme dans une pièce sombre) est noté. Un examen général, en particulier de la tête et du cou, et un [examen neurologique](#) complet sont réalisés.

Le cuir chevelu est examiné à la recherche de zones d'œdème et d'hypersensibilité. L'artère temporale homolatérale et les deux articulations temporomandibulaires sont palpées pour rechercher une douleur et un ressaut lorsque le patient ouvre et ferme la bouche.

Les yeux et la région périorbitaire sont examinés pour rechercher un larmoiement, un flush et une injection conjonctivale. Les diamètres pupillaires et la réponse à la lumière, les mouvements oculaires et le champ visuel sont évalués. Le fond d'œil est examiné à la recherche d'anomalie de la pulsation veineuse rétinienne spontanée et d'un [œdème papillaire](#). Si les patients ont des symptômes visuels ou des anomalies oculaires, l'acuité visuelle est mesurée. Lorsque la conjonctive est rouge, la chambre antérieure et la cornée sont examinées avec une lampe à fente si possible, et la pression intraoculaire est mesurée.

Les cavités nasales sont examinées pour rechercher un écoulement purulent. L'oropharynx est examiné à la recherche d'un œdème et les dents sont percutées.

La nuque est fléchie pour détecter une gêne et/ou une raideur, traduisant un syndrome méningé. Le rachis cervical est palpé à la recherche d'une douleur.

Signes d'alarme

Les signes suivants sont particulièrement préoccupants:

- Symptomatologie neurologique (p. ex., altération de la vigilance, asthénie, diplopie, œdème papillaire, déficit neurologique focal)
- HTA sévère
- Immunodépression ou cancer
- Méningisme
- Survenue de céphalées après l'âge de 50 ans
- Céphalées en coup de tonnerre (céphalées intenses qui atteignent leur maximum en quelques secondes)
- Symptômes d'artérite à cellules géantes (p. ex., troubles visuels, claudication de la mâchoire, fièvre, perte de poids, sensibilité de l'artère temporale, myalgies proximales)
- Symptômes généraux (p. ex., fièvre, perte de poids)
- Céphalées d'aggravation progressive
- Œil rouge et halos lumineux

Interprétation des signes

Si des céphalées présentant des caractéristiques similaires réapparaissent chez des patients qui semblent aller bien et dont l'examen est normal, la cause est rarement inquiétante. Des céphalées récidivantes apparues dans l'enfance ou chez l'adulte jeune suggèrent des céphalées primaires. Si le type de céphalée ou ses caractéristiques se modifient chez un patient qui a une céphalée primaire connue, une céphalée secondaire doit alors être évoquée.

Les symptômes isolés des troubles primaires de céphalées, autres que l'aura, ne permettent généralement pas d'identifier un diagnostic de façon spécifique. Les symptômes et signes qui se manifestent en association sont potentiellement plus caractéristiques d'un trouble spécifique (voir tableau [Certaines caractéristiques des céphalées selon leur cause](#)).

Les signes d'alarme suggèrent une cause (voir tableau [Associer les signes d'alarme à la cause des céphalées](#)).

TABLEAU

Associer les signes d'alarme à la cause des céphalées

Signes évocateurs

Causes

Signes évocateurs	Causes
Manifestations neurologiques (p. ex., altération de la vigilance, confusion, asthénie neurogène, diplopie, œdème papillaire , déficit neurologique focal)	Encéphalite , hématome sous-dural , hémorragie sous-arachnoïdienne , thrombose du sinus veineux cérébral , hémorragie intracérébrale , tumeur , autres lésions expansives intracrâniennes, hypertension intracrânienne
Immunodépression ou cancer	Infection du système nerveux central, métastases
Méningisme	Méningite , hémorragie sous-arachnoïdienne, empyème sous-dural
Survenue de céphalées après l'âge de 50 ans	Risque élevé d'affection grave (p. ex., tumeur, artérite à cellules géantes)
Céphalées en coup de tonnerre (céphalées intenses qui atteignent leur maximum en quelques secondes)	Hémorragie sous-arachnoïdienne
Association de fièvre, perte de poids, troubles visuels, claudication de la mâchoire, sensibilité de l'artère temporale et myalgies proximales	Artérite à cellules géantes
Symptômes généraux (p. ex., fièvre, perte de poids)	Cancer, infection par le VIH
Céphalées d'aggravation progressive	Céphalées secondaires
Œil rouge et halos lumineux	Glaucome aigu par fermeture de l'angle

Examens complémentaires

Souvent, le diagnostic peut être posé sans examen complémentaire. Cependant, certaines affections sévères peuvent nécessiter un examen urgent voire immédiat. Certains patients ont besoin d'examens dès que possible.

Une IRM (et peut-être une angiographie par résonance magnétique [IRM]) doit être pratiquée dès que possible devant l'un des signes suivants:

- Céphalées en coup de tonnerre
- Altération de l'état mental
- Méningisme
- [Œdème papillaire](#)

- Déficit neurologique focal aigu

Si l'IRM n'est pas immédiatement disponible, la TDM peut être utilisée.

Une neuro-imagerie, habituellement une IRM, doit également être réalisée chez les patients présentant l'un des signes suivants:

- Déficit neurologique focal d'apparition subaiguë ou incertaine
- Apparition récente
- Âge > 50 ans
- Cancer
- Infection par le VIH
- Modification des caractéristiques de la céphalée
- Diplopie

De plus, si une [méningite](#), une [hémorragie sous-arachnoïdienne](#), une [encéphalite](#), ou toute cause de [méningisme](#) est évoquée, une [ponction lombaire](#) avec analyse du liquide céphalorachidien doit être effectuée, en l'absence de contre-indication sur l'imagerie. En cas de céphalée en coup de tonnerre, l'analyse du liquide céphalorachidien est indispensable, même si l'imagerie et l'examen clinique sont normaux tant que la ponction lombaire n'est pas contre-indiquée par les signes d'imagerie. L'analyse du LCR est également habituellement indiquée si les patients qui ont des céphalées sont immunodéprimés ou s'ils ont un œdème papillaire.

La [tonométrie](#) doit être effectuée si les résultats suggèrent un [glaucome aigu à angle fermé](#) (p. ex., halos visuels, nausées, œdème cornéen, chambre antérieure étroite).

D'autres examens doivent être effectués dans les heures ou les jours qui suivent, selon l'intensité et la gravité des signes et les causes suspectées.

La VS et la protéine C réactive (CRP) doit être mesurée si les patients ont des symptômes visuels, une claudication de la mâchoire ou de la langue, des signes au niveau de l'artère temporale ou d'autres symptômes suggérant une artérite à cellules géantes.

Une TDM des sinus de la face est pratiquée afin d'éliminer une [sinusite](#) compliquée lorsque les patients ont une maladie systémique de gravité modérée (p. ex., fièvre élevée, déshydratation, prostration, tachycardie) et des signes suggérant une sinusite (p. ex., céphalée frontale, positionnelle, épistaxis, rhinorrhée purulente).

Une ponction lombaire avec analyse du liquide céphalorachidien est effectuée lorsque les céphalées sont progressives et que les signes suggèrent une [hypertension intracrânienne idiopathique](#) (p. ex., baisse transitoire de la vision, diplopie, acouphènes pulsatiles) ou une [méningite chronique](#) (p. ex., fièvre persistante de bas grade, neuropathies crâniennes, troubles cognitifs, ralentissement psychomoteur, vomissements).

Traitement des céphalées

Le traitement des céphalées est axé sur la cause, le type ou le diagnostic du trouble de la céphalée. Les céphalées primaires non migraineuses peuvent être traitées par une courte cure d'antalgiques non opioïdes; les médicaments opioïdes doivent être évités.

Points clés

- Les céphalées récidivantes apparues à un jeune âge, avec un examen clinique normal, sont habituellement bénignes.
- Une neuro-imagerie dès que possible est recommandée en cas de trouble de la vigilance, de crises convulsives, d'œdème papillaire, de déficit neurologique focal ou de céphalée en coup de tonnerre.
- L'analyse du LCR est nécessaire après une neuro-imagerie chez les patients qui ont un méningisme et habituellement chez les patients immunodéprimés et ceux qui ont un œdème papillaire.
- En cas de céphalée en coup de tonnerre, l'analyse du liquide céphalorachidien est indispensable, même si la neuroimagerie et l'examen clinique sont normaux tant que la ponction lombaire n'est pas contre-indiquée par les signes d'imagerie.



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.